

Skjervøy kommune



**PLAN FOR
HELSEMESSIG
OG
SOSIAL BEREDSKAP**

2013- 2016



Forord

Kommunen er pålagt å utarbeide plan for helsemessig og sosial beredskap, jfr. lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.juni 2000 nr. 56 med forskrift av 23.juli 2001 nr. 881.

Helse- og omsorgssjefen nedsatte i 2005 en komité med følgende medlemmer:

- Helse- og sosialsjefen (leder)
- Medisinsk faglig rådgiver
- Leder av Skjervøy sykestue og sykehjem
- Leder av hjemmetjenesten
- Leder av psykiatritjenesten
- Leder for omsorgsboligene i Malenaveien 2 og 4

Planen viser 3 beredskapsnivåer slik det er stilt krav om:

- Overordnet kriseledelse, jfr. overordnet kriseplan sist revidert
- Kriseledelse for helse- og omsorg
- Psykososialt team

Komitéen har brukt mye tid på å vurdere oppgaver, varslingssystemer m.m. internt i nivåene og mellom nivåene. Prinsipper og definisjoner for beredskapen har vært vektlagt.

Planen er i overensstemmelse med intensjonene i overordnet kriseplan med unntak av enkelte definisjonsbegrep og navneoversikter.

Komitéen har i sitt arbeid hatt sterkt fokus på at kommunen har etablert vaktordninger i **normalsituasjonen**. Disse vaktordningene er de grunnleggende ordninger også i **ekstraordinære situasjoner**.

De etablerte beredskapsordninger for akuttmedisinsk beredskap, brannberedskap, ambulanseberedskap, politiberedskap m.v. har prosedyrer for varsling, utrykking og handling på skadested. I denne planen beskrives ikke disse prosedyrene nærmere.

En plan for helsemessig og sosialberedskap inneholder navn, funksjoner og adresser. For at planen skal være et praktisk verktøy må planen med vedlegg oppdateres årlig.

Arbeidet med revidering av planen ble igangsatt i april/mai 2013 og da med følgende arbeidsgruppe:

- Helse- og omsorgssjefen (leder)
- Medisinsk faglig rådgiver
- Leder av Skjervøy sykestue og sykehjem
- Leder av hjemmetjenesten
- Leder av rus- og psykiatritjenesten
- Leder for omsorgsboligene i Malenaveien 2 og 4
- Leder av omsorgs- og avlastningsboligen

Skjervøy den 14.mai 2013

Lise Román

Helse- og omsorgssjef

KAP.1. INNLEDNING	6
1.1. MÅL FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP	6
1.2. LOVGRUNNLAGET	6
1.3. PRINSIPPER I BEREDSKAP SARBEIDET	6
1.4. DEFINISJONER	6
1.5. DEFINISJONER/PRINSIPPER	7
1.6. EKSEMPLER PÅ SITUASJONER SOM KREVER TILTAK	7
1.7. OPPBEVARING AV PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP	8
KAP. 2. SKJERVØY KOMMUNE	8
2.1. FOLKETALL OG AREAL	8
2.2. ORGANISERING AV KOMMUNENS ADMINISTRASJON	8
2.3. ORGANISERING AV HELSE- OG OMSORGSETATEN	9
2.4. VAKT- OG BEREDSKAPSORDNINGER I HELSE- OG OMSORGSETATEN I NORMALSITUASJONER	9
2.4.1. LEGETJENESTEN	9
2.4.2. SKJERVØY SYKESTUE OG SYKEHJEM	9
2.4.3. HJEMMESYKEPLEIEN	9
2.4.4. RUS- OG PSYKIATRITJENESTEN	10
2.4.5. OMSORGSBOLIGER I MALENAVEIEN 2 OG 4	11
2.4.6. AVLASTNINGS- OG OMSORGSBOLIGER SANDVÅGHAUGAN 2	11
2.4.7. SOSIAL- OG BARNEVERNSTJENESTEN	11
2.5. ANDRE VAKT- OG BEREDSKAPSORDNINGER	11
2.5.1. BRANNBEREDSKAP	11
2.5.2. EGEN TRYGGHETSORDNING FOR OMSORGSBOLIGENE	11
2.5.3. BEREDSKAPSKONTAKTER I DISTRIKTET	11
2.5.4. AMBULANSETJENESTEN	12
2.5.5. POLITIBEREDSKAP	12
2.5.6. MATTILSYNET	12
2.5.7. OVERGREPSMOTTAK VED LEGEVAKTEN I TROMSØ, JFR. VEDLEGG 10	12
KAP. 3. OVERORDNET KRISEPLAN	13
3.1. OM OVERORDNET KRISEPLAN	13
3.2. FORHOLDET MELLOM OVERORDNET KRISEPLAN OG PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP	13
3.3. OVERORDNET KRISELEDELSE, JFR. OVERORDNET PLAN SIDE 4	13
3.4. BESLUTNING OM ETABLERING AV KRISELEDELSEN	14
3.5. STED FOR ETABLERING AV KRISELEDELSEN	14
3.6. OPPGAVER FOR OVERORDNET KRISELEDELSE	14
3.7. INFORMASJON OG OPPGAVER FOR INFORMASJONSTJENESTEN	14
3.8. EVAKUERING OG OPPGAVER FOR EVAKUERINGSTJENESTEN	15
KAP. 4. KRISELEDELSE HELSE OG OMSORG	16
4.1. NÅR KAN DET VÆRE AKTUELT Å INNKALLE KRISELEDELSE FOR HELSE- OG OMSORG	16
4.2. KRISELEDELSEN HELSE- OG OMSORG	16
4.3. VARSLING	16
4.4. OPPGAVER FOR KRISELEDELSEN HELSE- OG OMSORG	16
4.5. FORHOLDET TIL OVERORDNET KRISELEDELSE	17
4.6. MØTESTED OG RAMMER	17

4.7. RESSURSER OG OMDISPONERING AV RESSURSER	17
4.8. EVAKUERING	18
4.8.1. SITUASJONER SOM KREVER EVAKUERING I AKUTTSITUASJON	18
4.8.2. OMSTILLING AV DRIFTA OVER TID	18
4.8.3. TRANSPORT	18
4.9. INFORMASJON	19

KAP. 5. PSYKOSOSIALT TEAM	20
----------------------------------	-----------

5.1. NÅR KAN DET VÆRE AKTUELT Å INNKALLE PSYKOSOSIALT TEAM	20
5.2. BRÅ OG UVENTA DØD	20
5.3. HVEM KAN KONTAKTE PSYKOSOSIALT TEAM	20
5.4. MEDLEMMER I PSYKOSOSIALT TEAM:	20
5.5. VARSLING	21
5.6. OPPGAVER FOR PSYKOSOSIALT TEAM	21
5.6. FORHOLDET TIL KRISELEDELSEN HELSE- OG OMSORG	21
5.7. MØTEPlass OG RAMMER	21
5.8. INFORMASJON	21

KAP. 6. DE MEST AKTUELLE KRISESITUASJONER	22
--	-----------

6.1. SITUASJONER SOM KREVER TILTAK	22
6.2. HENDELSER OG ANALYSER I OVERORDNET KRISEPLAN	22
6.3. HENDELSER MED SPEIELL KONSEKVENNS FOR HELSE- OG SOSIALETATENS BEREDSKAP	22
6.4. KONKRETE HENDELSER	22
6.4.1. BRANN I INSTITUSJONER OG OMSORGSBOLIGER	22
6.4.2. STRØMBRUDD OVER LENGRE TID	23
6.4.3. FORSVINNING AV BRUKERE/ PASIENTER	23
6.4.4. UTAGERENDE BRUKERE/ PASIENTER	23
6.4.5. ULYKKER MED STOR PERSONSKADE ELLER DØD FOR BRUKERE/PASIENTER	23
6.4.6. HENDELSER MED PERSONALET	23
6.4.7. EVAKUERING	23
6.4.8. UTSTYR OG RESSURSER	23
6.4.9. FOREBYGGING AV SMITTEEFFEKT VED SELVMORD OG SELVMORDFORSØK	23
6.5. ANDRE HENDELSER	23

KAP. 7. ØVELSER, HENDELSER OG KOMPETANSE	24
---	-----------

7.1. ØVELSE FOR KRISELEDELSEN I SKJERVØY 02.06.05	24
7.2. STRØMBRUDD I SKJERVØY KOMMUNE 31.DESEMBER 2004	24
7.3. HENDELSER HVOR PSYKOSOSIALT TEAM HAR VÆRT UTKALT	24
7.4. ANDRE ØVELSER - EKSEMPLER	24
7.5. KOMPETANSE	24

KAP. 8. HANDLINGSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER	25
---	-----------

8.1. ORGANISASJONSKART HELSE- OG OMSORGSETATEN	25
8.2. OVERSIKT OVER HELSEPERSONELL	25
8.3. OVERSIKT OVER BEBOERE OG PÅRØRENDE	25
8.4. SMITTEVERNPLAN	25
8.5. OVERORDNET KRISEPLAN	25

8.7. PROSEDYRER FOR LEGEVAKT OG EKSTRAORDINÆRE SITUASJONER	25
8.8. HANDLINGSPLAN VED EKSTRAORDINÆRE SITUASJONER FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN	25
8.9. PLAN FOR PSYKOSOSIALT TEAM	25
8.10. OVERGREPSMOTTAK VED LEGEVAKTEN I TROMSØ	26
8.11. LOVGRUNNLAGET	26
8.12. ROS ANALYSER FOR HENDELSER BESKREVET I KAP.6	26
8.13. ROS ANALYSER I OVERORDNET KRISEPLAN	26
8.14. LOGGSKJEMA OG RAPPORTERINGSSKJEMA	26

KAP.1. INNLEDNING

1.1. Mål for helsemessig og sosial beredskap

Kommunen skal sikre en god håndtering av situasjoner som oppstår og forebygge og avgrense skade på liv, helse, materielle verdier og miljø i egen og nærliggende kommuner.

Planen skal være et praktisk verktøy til bruk når det inntreffer uønskede hendelser som krever innsats utover det den enkelte virksomhet vil klare å takle på en tilfredsstillende måte innenfor det normale hjelpeapparat.

1.2. Lovgrunnlaget

Kommunen plikter å utarbeide en beredskapsplan for sine helse- og sosialtjenester i henhold til Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.juni 2000 nr. 56.

Sentrale lover og forskrifter finnes i vedlegg 11 til denne planen.

1.3. Prinsipper i beredskapsarbeidet

Ansvaret for å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsarbeid ligger hos den enkelte tjenesteprodusent. Dette har en sammenheng med at alt arbeidet for å styrke samfunnssikkerheten i Norge tar utgangspunkt i **ansvars-, likhets og nærhetsprinsippet** (St. melding nr. 17 (2001-2002)).

- **Ansvarsprinsippet** – betyr at den virksomhet som har ansvaret for en tjeneste i en normalsituasjon, også har et ansvar i en krisesituasjon
- **Likhetsprinsippet** – betyr at det skal være mest mulig likhet mellom organisering i en normalsituasjon og i en krisesituasjon
- **Nærhetsprinsippet** – betyr at kriser skal håndteres på lavest mulig nivå

1.4. Definisjoner

Normalsituasjon: En situasjon der oppgaven for virksomheten ikke er større enn at den kan håndteres med normal drift.

Ekstraordinær situasjon: En situasjon der oppgavene for virksomheten er så store at de ikke kan håndteres uten at aktiviteten blir lagt om og ekstra ressurser settes inn. Dette kan være ulykker, kriser og katastrofer i fredstid eller krig.

Beredskap: Evne til å kunne fortsette, utvide eller om nødvendig legge om aktiviteter og tjenester for å gi hjelp som trengs i situasjonen.

Beredskapsplan: En samling forberedte tiltak som kan settes i verk raskt i en ekstraordinær situasjon og en oversikt over det kontinuerlige beredskapsarbeidet.

Helsemessig og sosialberedskap: Helsemessig og sosial beredskap omfatter beredskap i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og sosialtjenesten i kommuner, fylkeskommuner og staten. Dette gjelder blant annet akuttmedisinsk beredskap, beredskap i ambulansetjenesten, kommunikasjonsberedskap, smittevernberedskap, næringsmiddel og drikkevannsberedskap, evakueringsberedskap, beredskap ved atomulykker og beredskap for forsyningstjenester og personell.

Handlingsplan: En del av beredskapsplanen der de forberedte tiltakene for handtering av ekstraordinær situasjon er fastsatt.

Kriseledelse: Overordnet administrativ og faglig ledelse i virksomheten ved ekstraordinære situasjoner. Det finnes en overordnet kriseledelse for hele kommunen, og en kriseledelse for helse- og omsorg.

Risiko: Den faren som uønskede hendelser representerer for menneske, miljø og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynlighet for en uønsket hendelse (frekvens) og konsekvensen av hendelsen.

Sårbarhet: En virksomhet eller organisasjons sin evne til å fungere og nå sine mål når den blir utsatt for påkjenninger.

1.5. Definisjoner/prinsipper i plan for helsemessig og sosial beredskap for Skjervøy

- Kommunen har etablerte vaktordninger i **normalsituasjoner**. Disse vaktordningene er de grunnleggende ordninger også i **ekstraordinære situasjoner** og skal ved behov kunne innkalle ekstra ressurser, jfr. kap. 1, pkt. 1.3 og 1.4, kap. 2, pkt. 2.3 og 2.4. (Helse- og omsorgssjefen og de ulike virksomhetsledere har ikke beredskapsordninger og kan være utilgjengelig.)
- Sykepleier legevaktsentral og vakthavende lege har derfor en meget sentral funksjon også i ekstraordinære situasjoner. Det samme gjelder for de døgnbemannede omsorgsboliger i Skoleveien 2 (rus- og psykiatritjenesten), omsorgsboligene i Malenaveien 2 og 4, omsorgs- og avlastningsboligene på Sandvågshaugen 2 og den somatiske hjemmetjeneste i tidsrommet 08 til 22.
- De etablerte beredskapsordninger for akuttmedisinsk beredskap, brannberedskap, ambulanseberedskap, politiberedskap m.v. har prosedyrer for varsling, uttrykking og handling på skadested. I denne planen beskrives ikke disse prosedyrene nærmere.

1.6. Eksempler på situasjoner som krever tiltak

- a) Akuttmedisinsk hendelse hvor situasjonen takles av akuttmedisinsk beredskap. Hendelsens omfang er grunnlaget for vurdering om å mobilisere overordnet kriseledelse, kriseledelse helse- og omsorg og/eller psykososialt team.
- b) Leteaksjoner med flere involverte med et ukjent antall skadde og pårørende. Overordnet kriseledelse er satt. Ordfører er ansvarlig for informasjon.
- c) Ekstremvær situasjoner med for eksempel strømbrudd. Kriseledelsen ved helse- og omsorg settes. Helse- og omsorgssjefen er informasjonsansvarlig.
- d) Leteaksjoner etter enkeltpersoner (brukere av pleie- og omsorgstjenester) Virksomhetsleder er ansvarlig. Helse- og omsorgssjefen orienteres og videre tiltak drøftes

1.7. Oppbevaring av plan for helsemessig og sosial beredskap

Planen med vedlegg (ringperm) skal være tilgjengelig på følgende steder:

- Helse- og omsorgsetatens ekspedisjon, Rådhuset 3. etasje (også lister over brukere/pårørende)
- Helsesenteret, sykepleierkontoret, Sandvågshaugan 1 (også lister over brukere/pårørende)
- Helsesenteret, hjemmetjenestens vaktrom, Sandvågshaugan 1, 2. etasje
- Legekontorets ekspedisjon, Sandvågshaugan 1
- Rus- og psykiatritjenesten, Skoleveien 2, vaktrom
- Omsorgsboliger Malenaveien 2 og 4, vaktrom
- Avlastnings- og omsorgsboliger Sandvågshaugan 2, vaktrom
- Helsestasjonen, Rådhuset 1. etasje hos ledende helsesøster
- Ordførerens kontor
- Rådmannens kontor

KAP. 2. SKJERVØY KOMMUNE

2.1. Folketall og areal

Skjervøy kommune har pr.1.januar 2013 innbyggere og har et areal på 477 km². Skjervøy er en øykommune med følgende bebodde øyer:

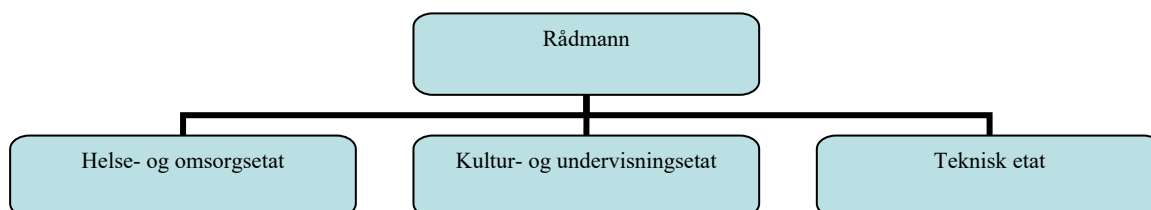
Skjervøy og Kågen	2460
Arnøy	418
Laukøy	17
Uløy	23
Vorterøy og andre steder hvor tall ikke er registrert	20
Totalt	2966

Tallene er henta fra SSB og de enkelte tallene stemmer ikke med sluttsummen, men dette gir et inntrykk av innbyggertall på tettsted og distrikt.

Mange bygder har en overvekt av eldre befolkning som kommunen må ha spesielt fokus på i ulike situasjoner. Arnøy, Laukøy og Uløy har kommunikasjon med tettstedet gjennom fergef forbindelse.

2.2. Organisering av kommunens administrasjon

Kommunen har følgende administrative organisering:



2.3. Organisering av helse- og omsorgsetaten

Helse- og omsorgsetaten er organisert i 9 virksomheter som rapporterer direkte til helse- og omsorgssjefen:

Virksomhet	Adresse
Helse- og omsorgssjefen	Rådhuset 3. etasje, Skoleveien 6
Sosial- og barneverntjenesten	Rådhuset 3. etasje, Skoleveien 6
Helsestasjonen	Rådhuset 1. etasje, Skoleveien 6
Legetjenesten	Helsesenteret, underetasje, Sandvågshaugan 1
Ergo – og fysioterapitjeneste	Helsesenteret, underetasje, Sandvågshaugan 1
Skjervøy sykestue og sykehjem	Helsesenteret 1. etasje, Sandvågshaugan 1
Hjemmetjenesten	Helsesenteret 2. etasje, Sandvågshaugan 1
Rus- og psykiatritjenesten inkludert omsorgsboliger	Skoleveien 2
Avlastnings- og omsorgsboliger	Sandvågshaugan 2, 1. etasje
Omsorgsboliger	Malenaveien 2 og 4

Det vises til organisasjonskart hvor virksomheter, hvilket personell som er ansatt i hver virksomhet og årsverk i virksomheten fremgår, jfr. vedlegg nr. 1.

2.4. Vakt- og beredskapsordninger i helse- og omsorgsetaten i normalsituasjoner

Vakt- og beredskapsordninger i normalsituasjoner må så langt som mulig omstilles til å fungere i ekstraordinære situasjoner. Det vises til prinsipper for beredskap og definisjoner under kap. 1, pkt. 1.3 og 1.4.

Det er derfor viktig å klarlegge vakt- og beredskapsordninger i normalsituasjonen.

2.4.1. Legetjenesten

Kommunen har 3 fastleger og 1 turnuslege i egen kommunal legevakt. Legevakttelefoner besvares av legekantoret i kontortida og gjennom legevaktsentralen på helsesenteret etter kontortid.

2.4.2. Skjervøy sykestue og sykehjem

Skjervøy sykestue har 6 plasser inkludert døgnplass for øyeblikkelig hjelp. Sykehjemmet har 18 ensengsrom og skjermet enhet har 9 ensengsrom.

Institusjonen har døgnbemanning med 3 nattevakter.

Det er sykepleier på vakt alle vakter.

2.4.3. Hjemmesykepleien

Hjemmetjenesten i kommunen er delt i somatisk og psykiatrisk hjemmetjeneste.

Hjemmetjenesten yter hjelp til hjemmeboende på tettstedet mellom kl. 08 og 22. På Arnøy mellom kl. 08 og 15 og ellers i distriktet ved behov.

Kommunen har ikke en døgnbemannet hjemmetjeneste.

Det er sykepleier på dagvakt.

Kommunen har følgende tilrettelagte boliger hvor beboerne får hjelp av hjemmetjenesten:

Bolig	Adresse	Tilbud
10 omsorgsboliger 2. etasje på Helsesenteret	Sandvågshaugan 1	Hjemmetjenesten mellom 8-22. Tilsyn fra sykestue og sykehjem om natta.
10 leiligheter Hybelhus for eldre	Skoleveien 4	Hjemmetjenesten mellom 8-22. Tilsyn fra rus- og psykiatritjenesten om natta
5 tilrettelagte leiligheter	Sandvågshaugan 2, 2. etasje	Hjemmetjenesten 8-22, jfr. vedtak om helsehjelp
8 leiligheter -Røde Kors	Severin Steffensens vei 20/22	Hjemmetjeneste kl.8-22, jfr. vedtak om helsehjelp
6 leiligheter Arnøyhamn eldrebolig	Arnøyhamn	Hjemmetjeneste kl. 8-22, jfr. vedtak om helsehjelp
11 leiligheter i ”Prix”bygget	Strandveien 46	Hjemmetjeneste kl. 8-22, jfr. vedtak om helsehjelp
Naustet	Strandveien 88	Hjemmetjeneste kl. 8-22, jfr. vedtak om helsehjelp

På **Arnøy** har kommunen hjelpepleier i 75% stilling. Dette er en viktig ressurs i normalsituasjonen og svært viktig i en ekstraordinær situasjon. Dessuten er det knyttet helsepersonell til enkeltbruker som også vil være ressurser i ekstraordinære situasjoner.

På Helsesenterets ekspedisjon er det nøkler til nøkkelbokser som er montert i forhold til trygghetsalarmer. Hjemmetjenestens kontor i Arnøyhamn skole har nøkler til Arnøyhamn eldrebolig.

2.4.4. Rus- og psykiatritjenesten

Rus og psykiatritjenesten er etablert i Skoleveien 2 og har ansvar for:

- Heldøgnstiltak for 7 beboere med psykiske lidelser i Skoleveien 2 med egne leiligheter og tilgang på felles areal
- Hjemmeboende personer med psykiske lidelser

Tjenesten har heldøgnsbemanning med sykepleier på dagtid

Hybelhus for eldre med 10 leiligheter over 2 etasjer er lokalisert i samme bygg og får tilsyn av psykiatritjenesten om natta.

I Skoleveien 2 ligger også aktivitetssenteret.

2.4.5. Omsorgsboliger i Malenaveien 2 og 4

Her er det 10 leiligheter for mennesker med utviklingshemming. Beboerne har tilgang til felles areal. Leilighetene er fordelt på 2 bygg og over 2 etasjer.

Her er det heldøgnsbemanning.

2.4.6. Avlastnings- og omsorgsboliger Sandvågshaugan 2

Her er det 4 omsorgsleiligheter og 3 avlastningsboliger. Det er tilgang på felles stuer og andre fellesrom.

Tiltaket har heldøgnsbemanning.

I 2. etasje ligger 5 tilrettelagte leiligheter med hjemmetjenester etter vedtak om helsehjelp.

2.4.7. Sosial- og barnevernstjenesten

Kommunens sosial- og barnevernstjeneste har kontor på Rådhuset 3.etg. Tjenesten har en daglig åpningstid fra 08-16(15 sommertid)

Det er ikke beredskapsordning i **sosialtjenesten** og dette vurderes ikke som nødvendig.

Det er ikke beredskapsordning for **barnevernstjenesten**. Dette har vært vurdert, men administrasjon og politikere fant ikke at en slik heldøgnsberedskap var påkrevd. Barnevernstjenesten vurderer fortløpende risikosituasjoner og er i beredskap i forhold til aktuelle kjente situasjoner. Tjenesten kan nås på mobiltelefon. Hvis tjenesten ikke er tilgjengelig og kan rykke ut, kan det gis råd og veiledning til annet personell. Det er laget prosedyrer som finnes på helsesenterets vaktrom.

2.5. Andre vakt- og beredskapsordninger

2.5.1. Brannberedskap

Brannberedskapen er en kommunalt organisert beredskap med egne prosedyrer for varsling, utrykking og handling på skadested. Prosedyrer fungerer og planen går ikke videre inn på dette.

2.5.2. Egen trygghetsordning for omsorgsboligene

Etaten har 3 omsorgsboliger med én person på nattevakt. For å trygge de ansatte i forhold til truende situasjoner på natt er det inngått avtale med brannberedskapen om utrykking til omsorgsboligene når ansatte opplever truende situasjoner.

2.5.3. Beredskapskontakter i distriktet

Liste over **beredskapskontakter** i distriktet utenfor tettstedet:

Sted	Navn	Mobiltlf.
Vorterøy	Jan Ole Johansen	995 66 905
Nikkeby	Jan Hansen	909 86 133
Lauksletta	Carl J. Bentsen	922 02 760
Arnøyhamn	Rolf Larsen	911 92 587
Årviksand	Pål Ottar Kristiansen	986 46 235
Uløybukt	Steinar Storelv	909 35 084

2.5.4. Ambulansetjenesten

Dette er en statlig beredskap med innarbeidede rutiner og prosedyrer for varsling, utrykking og handling på skadested. Ambulanseplan er oppdatert i 2013. denne planen breskriver ikke disse prosedyrene nærmere.

2.5.5. Politiberedskap

Dette er en statlig beredskap med innarbeidede rutiner og prosedyrer med varslingssystemer. Planen går ikke videre inn på dette.

2.5.6. Mattilsynet

Mattilsynet har egne prosedyrer.

2.5.7. Overgrepsmottak ved legevakten i Tromsø, jfr. vedlegg 10

KAP. 3. OVERORDNET KRISEPLAN

3.1. Om overordnet kriseplan

Planen ble utarbeidet i 2008 og sist revidert i august 2013 og har følgende hovedinnhold:

- Overordnet kriseledelse og kriseledelsens oppgaver
- Etablering av beredskapsråd og beredskapsrådets oppgaver
- Informasjon og oppgaver for informasjonstjenesten
- Evakuering og oppgaver for evakueringstjenesten
- Støtteapparat for mennesker i krise og oppgaver
- Redningsressurser
- Frivillige organisasjoner
- Varslingslister

3.2. Forholdet mellom overordnet kriseplan og plan for helsemessig og sosial beredskap

I pkt. 3.1. fremgår hovedinnholdet i overordnet kriseplan. Enkelte forhold i overordnet kriseplan som overordnet kriseledelse og oppgaver, informasjon og evakuering beskrives også i denne planen.

Når det gjelder beredskapsråd, redningsressurser, frivillige organisasjoner m.m. beskrives ikke disse her og man må da gå til overordnet plan for å finne dette. Dette begrunnes med at denne planen ikke må bli for omfattende og at man forutsetter at overordnet kriseledelse er etablert i slike tilfeller med mange berørte.

3.3. Overordnet kriseledelse, jfr. overordnet plan side 4

Etat/stilling	Adresse	Mail adr.	Telefon jobb	Mobil telefon
Ordfører Torgeir Johnsen	Rønning Østgaards vei 6		77 77 55 11	99 58 75 55
Rådmann Cissel Samuelsen	Strandveien 109		77 77 55 10	91 71 84 87
Teknisk sjef Yngve Volden	Lailafjellveien 13		77 77 55 20	41 63 49 07
Helse- og omsorgssjef Lise Román	Klaus Dreyers vei 12		77 77 55 50	99 24 00 18
Kultur- og undervisningssjef Arild Torbergesen	St. Hanshanshaugen 11		77 77 55 40	97 98 09 71
Økonomisjef Rune Stifjell	Klaus Dreyers vei 40		77 77 55 30	95 77 71 18
Saksbehandler beredskap Frode Schultz	Fjellveien 8		77 77 55 27	48 86 55 02
Informasjonsmedarbeid er Magnar Solbakken			77 77 55 03	41 21 98 69

3.4. Beslutning om etablering av kriseledelsen

Ordfører eller rådmann etablerer kriseledelsen.

3.5. Sted for etablering av kriseledelsen

Kriseledelsen etableres på Skjervøy Rådhus i Kommunestyresalen.

3.6. Oppgaver for overordnet kriseledelse

- 1) Innhente opplysninger og vurdere situasjonen i kommunen
- 2) Ta avgjørelser om å sette i verk tiltak for å hindre skader på personer og materielle verdier
- 3) Prioritere kommunens egne ressurser
- 4) Holde kontakt med rednings- og innsatsledelsen (brann, politi og redningssentral)
- 5) Utarbeide og sende ut informasjon via informasjonsstøttegruppen til egne ansatte, innbyggerne og media
- 6) Yte bistand til evakuering via støttegruppen for evakuering
- 7) Innkvartering og forpleining av forulykkede og redningsmannskaper via støttegruppen for evakuering
- 8) Sørge for at personer som har vært utsatt for store påkjenninger får hjelp fra kommunens psykososiale team
- 9) Sikre vann og strømforsyning
- 10) Rette opp skader på kommunikasjoner og andre anlegg
- 11) Gjennomføre rasjonerings- og regulerings tiltak
- 12) Rydde et skadested og yte en innsats for å beskytte miljøet
- 13) Gjennomføre forebyggende tiltak mot egen virksomhet
- 14) Avgi periodiske rapporter om situasjonen til Fylkesmannen

3.7. Informasjon og oppgaver for informasjonstjenesten

Det å kommunisere godt med befolkning, media og andre virksomheter i en krisesituasjon er svært viktig. Samordning av informasjonsformidling er svært viktig.

Informasjonsansvarlig	Ordfører Torgeir Johnsen
Nestleder	Rådmann Cissel Samuelsen
Informasjonsmedarbeider	Magnar Solbakken
Informasjonsmedarbeider	Frode Schultz
Informasjonsmedarbeider	(oppnevnes hvis behov)

Informasjonskontor etableres på Skjervøy Rådhus, Sentral administrasjonen 2. etasje.

Pressekonferanser skal foregå i Rådhuset, inngangspartiet (foajeen)

Samlingssted for pårørende (avskjermet for pressen): Kantina på Skjervøy rådhus og Formannskapssalen med inngang fra oversida. Reserveløsning er kantina på ungdomsskolen.

Oppgaver for informasjonstjenesten:

- 1) Innhente opplysninger om situasjonen og rapportere videre
- 2) Informasjonsleder gir kriseledelsen opplysninger om hvilken oppfatning han/hun har om informasjonsbehovet
- 3) Informere egne ansatte etter oppdrag fra kriseledelsen
- 4) Gi informasjon til publikum/pårørende etter oppdrag fra kriseledelsen
- 5) På oppdrag fra kriseledelsen skal informasjonstjenesten gi media informasjon om pressekonferanse, utlevere pressemeldinger fra kriseledelsen og henvise mediepersoner til oppholdsrom hvor de kan vente på mer informasjon
- 6) Henvise pårørende til rette vedkommende/sted (psykososialt team)
- 7) Henvise publikum til sted som er avskjermet fra pressen, hvor de kan vente videre på informasjon

Det vises til overordnet kriseplan side 6 og 7.

Informasjonstjeneste i forhold til kriseledelsen helse- og omsorg og psykososialt team blir beskrevet under kap.4. og 5.

3.8. Evakuering og oppgaver for evakueringstjenesten

Plan for evakuering av personer fra et skadeområde eller et utsatt område i kommunen til et annet område i eller utenfor kommunen.

Følgende skal lede og bistå politi/lensmann ved evakuering:

Evakueringsleder	FIG leder Astrid Hanne Hansen 95084491
Evakueringsmedarbeider	FIG medarbeider

Mannskapsressurser er:

- FIG Skjervøy
- Heimevernet
- Sjøheimevernet
- FIG Nordreisa

Oppgaver evakuering:

- 1) Evakuering kan iverksettes av politi/lensmann. I en krigssituasjon også av Fylkesmannen
- 2) Skaffe oversikt over evakueringsområdet(hvem som bor der m.m)
- 3) Informere befolkningen i det området som skal evakueres om hva de skal ta med seg og hvor de skal evakueres
- 4) Skaffe egnede transportmidler
- 5) Samle personer i egnede lokaler når ikke innkvarteringen kan skje direkte
- 6) Foreta registrering over hvem som innkvarteres hvor, hvem som flytter på egen hånd m.m.
- 7) Kontrollere at evakueringsområdet er tomt og sette ut vaktmannskaper
- 8) Samarbeide nært med LRS/skadestedsledelsen
- 9) Sørge for forpleining og eventuelt klær
- 10) Omsorgsfunksjon. Avtale med psykososialt team
- 11) Gi løpende informasjon til kommunens kriseledelse.

KAP. 4. KRISELEDELSE HELSE OG OMSORG

4.1. Når kan det være aktuelt å innkalle kriseledelse for helse- og omsorg

Ved en ekstraordinær hendelse varsles helse- og omsorgsjefen av vakthavende lege og/eller sykepleier legevaktsentral. Disse treffer beslutning om å sette kriseledelsen for helse- og sosial.

4.2. Kriseledelsen helse- og omsorg

Kriseledelsen helse- og omsorg varsles etter nedenforstående liste.

	Funksjon	Tlf.jobb	Mobiltlf.
Lise Román	Helse- og omsorgssjef	77775550	99240018
Paul Odberg	Medisinsk faglig rådgiver	Legevaktstlf.	
Åshild Hansen	Leder sykestue og sykehjem	77777042	97677426
Eldbjørg Nyvoll	Leder hjemmetjenesten	77777032	41274330
Pål S. Mathisen	Leder rus- og psykiatritjenesten	77775563	92028407
Trond Sigurdson	Leder Malenaveien 2 og 4	77775612	41416687
Lena Kvernfold	Leder Sandvåghaugen 2	77775682	99294639
Sissel Østvang	Ledende helsesøster	77775570	41637974
Yngve Volden	Brannsjef	77775520	41634907

4.3. Varsling

Varsling foregår slik:

- Vakthavende lege eller sykepleier legevaktsentral varsler kriseledelsen etter liste som fremgår av pkt. 4.2. Hvis helse- og omsorgssjefen ikke er tilgjengelig varsles neste på lista. Den av de tilstedeværende som står høyest på lista er leder av kriseledelsen og har delegeringsansvar.
- Resten av teamet innkalles til helsesenteret av den som varsles først. Berørt(e) virksomhetsleder(e) varsles først.
- Leder varsler rådmannen om at kriseledelsen er i arbeid. Rådmannen vurderer om ordfører skal varsles.

4.4. Oppgaver for kriseledelsen helse- og omsorg

- 1) Innhente opplysninger og vurdere situasjonen i kommunen
- 2) Ta avgjørelser om å sette i verk tiltak for å hindre skader på personer og materielle verdier
- 3) Prioritere kommunens egne ressurser og omdisponering av ressursene
- 4) Holde kontakt med rednings- og innsatsledelsen(brann, politi og redningssentral)
- 5) Utarbeide og sende ut informasjon via informasjonsstøttegruppen til egne ansatte, innbyggerne og media
- 6) Yte bistand til evakuering via støttegruppen for evakuering
- 7) Innkvartering og forpleining av forulykkede og redningsmannskaper via støttegruppen for evakuering

- 8) Sørge for at personer som har vært utsatt for store påkjenninger får hjelp fra kommunens psykososiale team
- 9) Gjennomføre forebyggende tiltak mot egen virksomhet
- 10) Avgi periodiske rapporter om situasjonen til ordfører eller rådmann
- 11) Leder har ansvar for loggføring, jfr. eget skjema vedlegg 14

Oppgavene i henhold til pkt. 4,5,6 og 7 er så omfattende at det er sannsynlig at den overordnede kriseledelsen er satt.

4.5. Forholdet til overordnet kriseledelse

Alle hendelser hvor kriseledelsen helse- og omsorg er satt skal varsles til overordnet kriseledelse. Det skal avklares hvordan krisen skal håndteres og hvem som har hovedansvaret.

Ved store hendelser skal den overordnede kriseledelsen overta ansvaret for håndtering av krisen.

4.6. Møtested og rammer

Møtested for kriseledelsen for helse- og omsorg er helsesenteret, møterom i hovedetasje.

Helse- og omsorgssjef vil sammen med virksomhetsleder så snart råd er, vurdere behovet for ekstra ressurser.

Informasjonsansvar i henhold til overordnet kriseplan: Ordfører/rådmann

4.7. Ressurser og omdisponering av ressurser

Helse- og omsorgsetatens virksomheter fremgår av organisasjonskart, jfr. vedlegg.1

Vaktberedskapen i etaten fremgår av kap. 2, pkt. 2.4.

Tilgjengelige ressurser fremgår av oversikt over helse- og omsorgspersonell, jfr. vedlegg 2.

I ekstraordinære situasjoner må følgende vurderes:

- 1) Omdisponere personellressurser slik minimumsbemanning ivaretas
- 2) Innkalle ekstraressurser, jfr. voersikt over helsepersonell

Virksomhet	Dag/etter-middag/natt - ukedager	Dag/etter-middag/natt - helg	Omdisponeres, ukedag og / helg
Sykestue og sykehjem	8/6/2	7/5/2	7/4/1 og 5/3/1
Solkroken	4/2/1	3/2/1	3/1/0 og 2/1/0
Hjemmesykepleien	6/5/0	3/3/0	2/1 og 2/1
Rus- og psykiatri	4/2/1	1/2/1	3/1/0 og 0/1/0
Malenaveien 2 / 4	4/3/1	3/2/1	2/2/1 og 2/2/1
Avlastnings- og omsorgsboliger	3/3/1	3/3/1	2/2/0
Helsesøstre og sykepleier helsestasjon	2 på dagtid	0	2 på dagtid

I alle tilfeller en kan tenke seg vil det være aktuelt å omdisponere personell til helsesenteret fordi den ekstraordinære situasjonen ivaretas der.

4.8. Evakuering

4.8.1. Situasjoner som krever evakuering i akuttsituasjon

Ved ekstreme vær-situasjoner (med for eksempel storm, flom, ras), brann, ulykker som resulterer i behov for evakuering hvor følgende kan ha skjedd:

- a) Beboere kan ikke oppholde seg i bygningen
- b) Det skal gis plass til andre pasienter

Evakuering i forhold til pkt. a)	Evakueres til:
Helsesenterets beboere	SVS/ungdomsskolen/ hotellet
Skoleveien 2 og 4	Helsesenteret
Malenaveien 2 og 4	Skoleveien 2, Aktivitetssenteret
Avlastnings- og omsorgsboliger	Helsesenteret og pårørende
Hjemmetjenestens beboere – psykiatriske pasienter og somatisk hjemmesykepleie	Skoleveien 2, Aktivitetssenteret eller Helsesenteret stue "nord" i 2. etasje

Evakuering i forhold til pkt. b) til reservepleiestasjoner:
Helsesenteret. Reservepleiestasjon 2. etasje stue "nord". Deretter stue i 2. etasje og stuer i hovedetasje
Skoleveien 2 : Reservepleiestasjon Aktivitetssenteret. Deretter stuer i 1. og 2. etasje på Hybelhuset
Sandvågshaugen 2: Ledige leiligheter og avlastningsboliger benyttes
Sandvågshaugen 1: Treningsal fysioterapi-tjenesten
Legekontoret: Venterom

4.8.2. Omstilling av drifta over tid

Ved langvarig behov for omstilling av drifta, må situasjonen vurderes så raskt som mulig. Her må det vurderes å legge flere pasienter på samme rom, benytte reservepleiestasjoner eller finne ordninger i samarbeid med andre kommuner.

4.8.3. Transport

Alt av utstyr som fremgår av evakuering i overordnet kriseplan pkt. 3 må kunne stilles til disposisjon:

- Brann/teknisk etat har biler som må benyttes
- Ambulansetjenestens biler
- FIG enheten, jfr. kap. 3, pkt. 3.8

Helse- og omsorgsetaten disponerer følgende biler:

- Psykiatritjenesten: 3 biler parkert ved Skoleveien 2/garasje Rådhuset
- Hjemmetjenesten: 3 biler parkert i garasje på helsesenteret og 1 bil i distriktet
- Sykestua og sykehjemmet: buss med 8 plasser tilpasset rullestolbrukere
- Omsorgsboliger Malenaveien 2 og 4: buss med 8 plasser tilpasset rullestolbrukere
- Omsorgsboliger Sandvågshaugen: 1 buss tilpasser rullestolbrukere

4.9. Informasjon

Ved større ulykker vil den overordnede kriseledelsen bli satt og de prosedyrer som fremgår av overordnet kriseplan pkt. 3 følges. Dette gjelder også informasjonsansvar.

KAP. 5. PSYKOSOSIALT TEAM

5.1. Når kan det være aktuelt å innkalle psykososialt team

- Kriser og katastrofer der kommunens kriseledelse er etablert
- Større ulykker som berører flere personer som bor eller oppholder seg i kommunen
- Brå og uventet død eller alvorlig skade hvor særlig barn og unge er berørt
- Selvmord eller selvmordforsøk hvor støtte fra teamet vurderes som hensiktsmessig

5.2. Brå og uventa død

Det vil ikke alltid i situasjoner ved plutselige og uventede dødsfall være aktuelt å innkalle psykososialt team. Fastlegen må ha fokus på kontakt med pårørende slik at pasienten får tilbud om hjelp. Eller fastlegen må vurdere om andre i helsevesenet skal kontaktes for deretter å ta kontakt med pårørende.

5.3. Hvem kan kontakte psykososialt team

- Overordna kriseledelse og kriseledelsen helse- og omsorg kan mobilisere psykososialt team
- Skoler og barnehager har ansvar for å ta kontakt med psykososialt team når det er behov for bistand og hjelp
- Politi, vakthavende lege, sykepleier ved legevaktsentral, prest, ordfører, helse- og sosialsjef og medlemmer av gruppa har et spesielt ansvar for å melde fra
- Alle innbyggere i Skjervøy kommune kan kontakte teamets medlemmer
- Nærliggende kommuner til Skjervøy kan kontakte teamet når innbyggere i Skjervøy er berørt av en krise/hendelse og krisen håndteres av annen kommune

5.4. Medlemmer i psykososialt team:

Navn	Tittel	Tlf.jobb	Mobiltlf.
Pål S. Mathiesen	Leder/ psykiatrisk sykepleier	77775563	92028407
Helga Molnar	Nestleder/Lege		Ring legevakt
Eldbjørg Nyvoll	Leder hjemmetjenesten	77775732	41274330
Sissel Eriksen	NAV/sosial tjenesten	90813479	98850099
Sissel Østvang	Ledende helsesøster	77775570	41637974
Ilmi Angell	Psykiatrisk sykepleier	777754600	48064610
Odd Hardang	Psykolog		92207898
Yngve Volden	Teknisk sjef	77775520	41634907
	Sokneprest	77777540	97063827
Trond-André Haugseth	Politioverbetjent		02800

5.5. Varsling

Varsling foregår slik:

- Vakthavende lege ber sykepleier ved legevakt varsle teamet
- Sykepleier ved legevakt varsler ett medlem i teamet, jfr. prosedyre på legevaktsentralen
- Resten av teamet blir innkalt til helsesenteret av den som varsles først
- Teamet informerer helse- og omsorgssjefen når teamet er i arbeid
- Helse- og omsorgssjefen informerer rådmann

Det er laget egen plan for psykososialt team, jfr. vedlegg 9.

5.6. Oppgaver for psykososialt team

- Samordning av tiltak som rammer mennesker i forbindelse med ulykker, uventet dødsfall, selvmord og selvmordforsøk
- Å hjelpe barn med foreldre i akutt krise
- Støtte til pårørende
- Støtte innsatspersonell
- Være til hjelp i barnehager og skole ved uventet dødsfall hos barn, søsken og foreldre
- Tilrettelegging for kurs relatert til kriser og sorgarbeid
- Det skal føres logg for arbeid i psykososialt team, jfr. eget skjema i vedlegg 14

5.6. Forholdet til kriseledelsen helse- og omsorg

Helse- og omsorgssjefen skal varsles når psykososialt team er utkalt. Det skal da drøftes og avklares hvorvidt det er behov for a) sette kriseledelsen helse- og omsorg eller b) om helse- og omsorgssjefen skal be ordfører/rådmann sette den overordnede kriseledelsen.

Hvis helse- og omsorgssjefen ikke er tilgjengelig varsles rådmannen.

Helse- og omsorgssjefen varsler overordnet kriseledelse v/ordfører når psykososialt team er/har vært utkalt.

5.7. Møteplass og rammer

Møterom på helsesenteret.

5.8. Informasjon

Informasjons ansvarlig i henhold til overordnet kriseplan: ordfører og rådmann

KAP. 6. DE MEST AKTUELLE KRISESITUASJONER

6.1. Situasjoner som krever tiltak

For å eksemplifisere og for å lage en inndeling av hendelser som krever at overordnet kriseledelse og/eller kriseledelse helse- og omsorg og/eller psykososialt team settes, er ulike hendelser beskrevet i kap. 1, pkt. 1.6.

6.2. Hendelser og analyser i overordnet kriseplan

Det er utarbeidet en hendelsesoversikt og grovanalyse for i alt 25 ulike hendelser som følger som vedlegg 13 til denne planen. Her beskrives hendelsen, sannsynlighet, konsekvens og dagens beredskap.

Komitéen som har arbeidet med plan for helsemessig og sosial beredskap har ikke utarbeidet nye risikovurderinger på disse områdene. Nye og oppdaterte ros-analyser må gjøres i forbindelse med oppdatering av overordnet plan.

Avhengig av hendelsens omfang vil overordnet kriseledelse, kriseledelse helse- og omsorg eller psykososialt team bli satt. Oppgavene fremgår i henholdsvis kap.3, 4 og 5.

6.3. Hendelser med spesiell konsekvens for helse- og sosialetatens beredskap

Risiko= sannsynlighet x konsekvens

Det er gjort nøye vurderinger av hvilke hendelser som er ekstraordinære og som krever omstilling av drift og hvor det er påkrevd å sette kriseledelsen for helse- og omsorg og/eller psykososialt team.

Disse vurderinger fremgår av Handlingsplan med ressursoversikter og tiltakskort for pleie- og omsorgstjenesten, vedlegg 8.

Det er utført ros- analyser for aktuelle hendelser, jfr. vedlegg 12.

Det er videre gjennomført ros-analyser for ulike hendelser i avlastnings-og omsorgsboligene i forhold til ikke ekstraordinære situasjoner.

Hver enkelt virksomhet i pleie- og omsorgstjenesten har prosedyrer for tiltak i situasjoner som takles i forhold til normal drift. Disse oppbevares i egne ringpermer i virksomheten.

6.4. Konkrete hendelser

6.4.1. Brann i institusjoner og omsorgsboliger

Brann er en hendelse som er vurdert av alle virksomheter i pleie- og omsorg og hvor risikoen er avhengig av alder på bygget, forebyggende tiltak brann, brannvernleder og brannøvelser. Det vises til handlingsplaner og tiltakskort for hver virksomhet, jfr. vedlegg 8 og ros analyse, jfr. vedlegg 12.

6.4.2. Strømbrydd over lengre tid

Dette er en situasjon kommunen har opplevd.

Konsekvensen av hendelsen er liten for Helseneteret, avlastnings- og omsorgsboligene Sandvåghaugen 2 og omsorgsboligene i Skoleveien 2 som alle er tilkoblet nødstrøm.

Omsorgsboligene i Malenaveien 2 og 4 har ikke nødstrøm og konsekvensene og handlingene fremgår av tiltakskort.

For hjemmeboende i somatisk og psykiatrisk hjemmetjeneste er det laget egne tiltakskort.

Det vises til handlingsplan med tiltakskort, jfr. vedlegg 8 og ros- analyse, jfr. vedlegg 12.

6.4.3. Forsvinning av brukere/ pasienter

Her er det foretatt risikoanalyser for alle virksomheter innenfor pleie- og omsorg hvor alle har prosedyrer og noen har egne tiltakskort jfr. vedlegg 8 og vedlegg 12.

6.4.4. Utagerende brukere/ pasienter

Det er foretatt risikoanalyser. Noen virksomheter har prosedyrer og tiltakskort, jfr. vedlegg 8 og 12.

6.4.5. Ulykker med stor personskade eller død for brukere/pasienter

Her er det foretatt risikoanalyser for alle virksomheter innenfor pleie- og omsorg hvor det er utarbeidet prosedyrer og tiltakskort etter behov, jfr. vedlegg 8 og 12.

6.4.6. Hendelser med personalet

Det tenkes her på at store deler av personalet rammes av influensa eller annen sykdom. Det er foretatt en vurdering av omstillinga av drifta, jfr. kap. 4, pkt. 4.7 og vedlegg 8 og 12.

6.4.7. Evakuering

Det er ulike grunner til evakuering av pasienter, jfr. kap. 4, pkt. 4.8.1 a).

Planen beskriver i kap. 4, pkt. 4.8.1.b) evakueringssteder for ulike pasienter/brukere.

Evakuering er beskrevet både i overordnet plan og i denne planen.

6.4.8. Utstyr og ressurser

I handlingsplan ved ekstraordinære situasjoner for pleie- og omsorgstjenesten er det ressursoversikter hvor lager for mat, medisiner, madrasser/sengetøy, transportmidler m.m fremgår.

6.4.9. Forebygging av smitteeffekt ved selvmord og selvmordforsøk

Dette er en hendelse hvor det er viktig å ha fokus på smitteeffekt i ungdomsmiljøene.

Det er laget eget tiltakskort for denne hendelsen som ligger som vedlegg til plan for psykososialt team, vedlegg 9.

6.5. Andre hendelser

I pkt. 6.4. fremkommer de hendelsene som er vurdert pr. juni 2013. Ved oppdatering av planen vil det kunne være andre hendelser som må vurderes i tillegg.

KAP. 7. ØVELSER, HENDELSER OG KOMPETANSE

7.1. Øvelse for kriseledelsen i Skjervøy 02.06.05

Fylkesmannens i Troms v/Samfunnssikkerhet og beredskapsstaben gjennomførte øvelse med kriseledelsen i Skjervøy den 2.juni 2005. Det vises til rapport datert 10.06.05.

7.2. Strømbrudd i Skjervøy kommune 31.desember 2004

Denne hendelsen førte ikke til at overordnet kriseledelse ble satt.

Kriseledelsen helse- og omsorg ble satt.

Det ble innkalt til møte etter hendelsen hvor prosedyrer ble gjennomgått, jfr. referat datert 13.01.05. Denne hendelsen var en viktig læresituasjon for å vurdere egen beredskap.

Nye prosedyrer ble laget etter hendelsen.

7.3. Hendelser hvor psykososialt team har vært utkalt

Psykososialt team har vært i 0 oppdrag i 2012 og 1 pr. september 2013. Det er ført logg.

Evaluerer at psykososialt team handlet i henhold til egne prosedyrer.

7.4. Andre øvelser - eksempler

- Det gjennomføres regelmessige brannøvelser ved helsesenteret inkludert omsorgsboligene i 2. etasje
- Det gjennomføres regelmessige brannøvelser i Skoleveien 2 som også omfatter Hybelhus for eldre
- Skjervøy sykestue og sykehjem har gjennomført øvelser hvor pleiepersonalet er omstilt til å ivareta akutsituasjoner på sykestua. Kjøkken- og renholdspersonell har overtatt pleieoppgaver
- Det er i samarbeid med Sivilforsvaret gjennomført øvelse i forhold til akuttberedskap
- Skjervøy har vært støttekommune i forbindelse med Barents Rescue i september 2013. Kriseledelsen ble satt og det ble øvd med fokus på evakuering.

7.5. Kompetanse

- Øvelsene overfor øker kompetansen hos de som deltar
- Utarbeiding av denne planen har økt kompetansen om krisehandling og dette vil igjen få innvirkning på handlingskompetansen i en reell situasjon
- Skjervøy kommune har vært prosjektkommune for POSOM prosjektet. Prosjektgruppa har bestått av helse- og sosialsjefen, leder for hjemmetjenesten og leder for psykiatritjenesten og 3 fra Fylkesmannen i Troms. De 6 Nord-Troms kommunene deltok i POSOM 1. Alle kommunene i Troms ble invitert til POSOM 2. Senter for krisepsykologi i Bergen var faglig ansvarlig for POSOM 2
- Førstehjelpskurs årlig for fast ansatte og vikarer
- Helse- og omsorgssjefen og 4 fra kommunens ledelse har deltatt i flere kurs, sist i Risikoanalyse og risikostyring arrangert av Kommunal kompetanse oktober 2007
- Skjervøy kommunes overordnede organisering og organisering av helse- og omsorgsetaten er preget av stabilitet og klare roller i normalsituasjoner. Dette bidrar også til større mulighet for å takle omstilling til ekstraordinære situasjoner

KAP. 8. HANDLINGSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER

8.1. Organisasjonskart helse- og omsorgsetaten

Organisasjonskartet er oppdatert pr. april 2013. Dette gir en oversikt over virksomhetene i helse- og omsorgsetaten, ledelsen, personellkategorier og antall årsverk i den enkelte virksomhet. Organisasjonskartet oppdateres pr. november hvert år. Vedlegg 1

8.2. Oversikt over helsepersonell

Oversikt over ansatte i hver virksomhet, med navn, utdanning/funksjon, mobil/tlf./telefon privat og adresse. Oversikten er oppdatert pr. juni 2013. Oversikten oppdateres pr. november hvert år. Vedlegg 2

8.3. Oversikt over beboere og pårørende

Oversikt over beboere på sykehjem, omsorgsboliger, tildelte boliger finnes i ringperm for plan for helsemessig og sosialberedskap på sykepleierkontoret på Helsesenteret og tilsvarende perm i ekspedisjonen for helse- og omsorgsetaten på Rådhuset, 3. etasje. Oversikten oppdateres fortløpende ved endringer. Vedlegg 3

8.4. Smittevernplan

Planen er sist revidert pr. desember 2000. Planen er gjennomgått i forbindelse med utarbeidelse av plan for helsemessig og sosial beredskap og vurderes som meget funksjonell og med små behov for endringer. I tillegg til de utarbeidede prosedyrer, se s.55 – 61, vil det bli utarbeidet ny prosedyre på pandemi. Vedlegg 4

8.5. Overordnet kriseplan

Planen ble utarbeidet i 2008 og oppdatert pr. august 2013 Vedlegg 5

8.7. Prosedyrer for legevakt og ekstraordinære situasjoner

Legekontoret har egen prosedyreperm for legevakt og ekstraordinære situasjoner som er kontrollert og godkjent av fylkeslegen. Vedlegg 6

8.8. Handlingsplan ved ekstraordinære situasjoner for pleie- og omsorgstjenesten

Det er utarbeidet egen handlingsplan med ressursoversikter og tiltakskort for Skjervøy sykestue og sykehjem, hjemmetjenesten, psykiatritjenesten og Skoleveien 2, omsorgsboliger Malenaveien 2 og 4 og avlastnings- og omsorgsboligene Sandvågshaugen 2. Vedlegg 7

8.9. Plan for psykososialt team

Plan for psykososialt team med tiltakskort for hendelse: Forebygging av smitteeffekt ved selvmord og selvmordforsøk. Vedlegg 8

8.10. Overgrepsmottak ved legevakten i Tromsø

Retningslinjer ved spørsmål om overgrep.

Vedlegg 9

8.11. Lovgrunnlaget

Sentrale lover og forskrifter finnes i Helse- og omsorgsetatens ekspedisjon. Oversikt over lover og forskrifter finnes som vedlegg.

Vedlegg 10

8.12. ROS analyser for hendelser beskrevet i kap.6

Vedlegg 11

8.13. ROS analyser i overordnet kriseplan

Det vises til overordnet kriseplan med oversikt over hendelser og ROS analyse med hendelsesoversikt og grovanalyse.

Vedlegg 12

8.14. Loggskjema og rapporteringsskjema

Maler for loggføring og skjema for rapportering til overordnet nivå.

Vedlegg 13